c/46

EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS Nº EGRESO : 73006
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-10-25 10:14:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: PEDRO JUAN MEDEL MENDEZ			RUN	: 4.865.257-3
F.Nac	: 02-01-1943	Edad	: 80 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: HUENUTIL DE LA CABRERIA			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-10-15	Fecha Egreso	: 2023-10-25 10:14:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico occipital mesial-esplenio izquierdos y fronto-opercular derecho, c/TH PH-2, obs cardioembólico
-AKI postrenal en resolución
-Neumonía aspirativa inferior derecha, tto completado (4 dias de pip/tazo, 4 dias de ceftriaxona)
-Conjuntivitis bacteriana resuelta
-Hipernatremia e hipokalemia resueltas

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

HISTORIA CLÍNICA
PTE CON CUADRO CLINICO DE MAS DE 3 DIAS DE EVOLUCION CARACTERIZADO POR DISARTRIA , Y PERDIDA DE LA FUERZA MIUSCULAR EN HEMICUERPO IZQUIERDO LAB DESTACA PCR 21 CREAT 0.80 GLIC 121 ELP 149/3.70/101 HB 13.2 HTO 39.6 PLAQ 138000 LEUC 8100 INR 1.12 TROPO 541. NO HAY EKG DE INGRESO NI REFIEREN CUADRO DE DOLOR TORACICO HOY EN SALA HDN ESTABLE. CON HERIDA EN PABELLON AURICULAR IZQUIERDO POR CAIDA? CARDIOPULMONAR: MP+ CON RONCUS BILATERALES. RSCSRS S/S ABDOMEN: PLANO, BD I. RH+ NEUROLOGICO: VIGIL, ORIENTADO EN PERSONA, DESORIENTADO EN T Y E, LENGUAJE DISARTRICO, NOMINA 2/3 REPITE 2/3. PUPILAS ISOCORICAS RFM +, CV IMPRESIONA HEMIANOPSIA DERECHA CON REFLEJO DE AMENAZA, PFC LEVE IZQ, NO PROTRUYE LENGUA , HEMIPARESIA BRAQUIOCRURAL IZQUIERDA M3+, HEMICUERPO DERECHO ALCANZA M5, ROT +, CUTANEO PLANTAR EXTENSOR IZQUIERDO, INDIFERENTE DERECHO, SENSIBILIDAD ALGESICA IMPRESIONA DISMINUIDA EN HI, PRUEBAS CEREBRLOSAS POCO EVALUABLE PTE POCO COLABORADOR , SIGNOS MENINGEOS NEGATIVOS EKG RS, ONDAS T NEGATIVAS EN V5-V6 ANGIOTAC DE CEREBRO Y CUELLO: ATEROMATOSIS CAROTIDEA Y VERTEBRAL SIN FOCOS ESTENOTICS SIGNIFICATIVOS. TAC CEREBRAL : INFARTO DE ASPECTO AGUDO SUBAGUDO OCCIPITAL MESIAL DERECHO CON PETEQUIADO HEMORRAGICO CON EDEMA PERILESIONAL CONDICIONANDO EFECTO DE MASA , INFARTO CORTICAL FRONTAL GIROPRECENTRAL E INSULAR DERECHO

Evolución
Paciente en BEG, HDN estable con ocasional tendencia a la HTA, sin requerimientos de O2, eupneico, afebril, RS al monitor, se observa tranquilo, cooperador, niega molestias, sin tos ni necesidad de aspiración de secreciones bronquiales, tolera bien alimentación VO y KNTM, marcha con 1 operador.

Completo tto ATB por neumonía por aspiración y conjuntivitis bacteriana. Cursó con AKI.
Exs de lab muestra GB normales, PCR en descenso, regresión de AKI (posterior a instalación de sonda vesical), ELP N.
TC cerebro de control muestra regresión significativa de lesiones hemorrágicas.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy, IC HODOM, mantener sonda vesical, iniciar AAS y control ambulatorio en policlínico de Neurología.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-IC HODOM Fonoaudiología + KNTM + Kinesiología 2-3 veces/semana
-Mantener sonda vesical
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología

Dr. Saulo Venegas Figueroa
Rut: 16.138.950-1
Neurólogo
Universidad de Chile

INDICACIONES AL ALTA

1. -Atorvastatina 40 mg/noche
2. -Losartan 50 mg/d
3. -Hidralazina (50 mg) 1/2 comp c/8h
4. -Tamsulosina 0.4 mg/día
5. -Aspirina 100 mg/d
6. -Famotidina 40 mg/día

EXÁMENES Y RESULTADOS

25/10/23
-Crea 1.1 MDRD 64.41 Uremia 37
-PCR 55.9
-Na 144 K 3.6 Cl 105
-Hb 12.7 Leu 8300 Plaq 103000 Seg 75

24/10/23
-Crea 1.6 MDRD 41.8 Uremia 49
-AU 7.2
-Ca 7.2 P 3.6 Na 148 K 3.3 Cl 112
-PCR 60.7
-Hb 12.4 Leu 9700 Plaq 102000 Seg 80
-Procal 0.18

22/10/23
-Crea 1.6 MDRD 41.8 Uremia 53
-PCR 65.3
-Na 140 K 3.6 Cl 111
-Hb 13.3 Leu 10100 Plaq 117000 Seg 77

21/10/23
-Alb 3
-Crea 1.2 MDRD 58.26 Uremia 46
-Ca 7.8 Ca corr 8.6
-Na 151 K 2.9 Cl 112
-Leu 9600 Hb 12.6 Plaq 119000 Seg 77
-GSA pH 7.49 CO2 38.2 HCO3 29.6

20/10/23
-Crea 1 MDRD 71.9 Uremia 56
-PCR 73.9
-Ca 7.8 Ca io 0.5 Na 155 K 3 Cl 115
-Leu 9700 Hb 13.2 Plaq 131000 Seg 76 VHS 17
-ProBNP 1752

-Trop 658.2
-Procal 0.12
-GSA pH 7.47 CO2 32.6 HCO3 24.2

19/10/23
-Crea 1 MDRD 71.9 Uremia 69
-Ca 8.2
-CKMB 49 CK 312
-LDH 474
-Lact 0.9
-Na 142 K 3 Cl 114
-Hb 12.7 Leu 11900 Plaq 125000 Seg 80
-proBNP 978
-Trop 727.6
-Procal 0.12
-GSA pH 7.52 CO2 33.2 HCO3 27.5

18/10/23
-Trop 1173
-Procal 0.14
-Leu 13800 Hb 13.3 Plaq 113000 Seg 85
-Crea 1 MDRD 71.9 Uremia 93
-Na 152 K 3.2 Cl 114 Ca 8 Ca corr 8.48 P 3.1
-FA 241 BI 0.6 BD 0.1 BT 0.7 GOT 96 GPT 45 GGT 29
-CKT 613
-Lact 0.9

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación impresiona N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T soplos sistólicos aórtico y mitral 2/6
-Pulmonar: MP(+) SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), globo vesical(-)
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos +/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, desorientado en T-E, confusión leve, lenguaje +-fluente, nominación 3/3, repite frases de longitud mediana, comprende órdenes de 3 pasos sin cruzar linea media, resto n/e por confusión
-PC: CV por amenaza impresiona hemianopsia derecha, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izq leve, disartria leve, nistagmo(-), úvula central, lengua central, resto n/e
-Motor: impresiona M4-5 bilateral simétrico, RCP extensor bilateral
-Sensitivo: algesia impresiona conservada en las 4 EE
-Cerebelo: n/e por inatención
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO